

성인 Daily Day 02 — 고혈압 추적

1차진료

만성질환 추적

KCD I10

작성일 2026-05-13

오늘의 목표

재진에서 약을 올릴지, 다른 계열을 붙일지, 부작용 때문에 바꿀지, 상급병원으로 보낼지 결정한다. 핵심은 가정혈압 평균, 실제 복용, 부작용, 신기능/전해질이다.

1. 배경지식

고혈압 추적 진료는 로컬 의원 만성질환 관리의 가장 흔한 반복 업무다. 실패 원인은 약제가 약해서라기보다 가정혈압 확인 부족, 복용 누락, 염분/음주, NSAID·감기약·스테로이드, 수면무호흡, 부작용으로 인한 임의 중단이 많다.

기본 목표는 진료실 혈압 140/90 mmHg 미만, 가정혈압 135/85 mmHg 미만이다. 다만 고령, 기립저혈압, frailty, CKD, 당뇨, 심혈관질환 동반 여부에 따라 목표와 속도를 개별화한다.

단독요법으로 목표에 도달하지 못하면 같은 약을 무리하게 최대용량까지 밀기보다 서로 다른 계열의 저용량 병합이 실용적이다. RAS blocker, CCB, thiazide/thiazide-like diuretic 조합이 추적 진료의 기본 축이다.

2. 첫 3분 Triage

즉시 ER: 180/120 mmHg 전후 이상 + 흉통, 호흡곤란, 신경학적 결손, 의식 변화, 시야장애, 폐부종, 급성 신손상 의심. 대동맥박리, ACS, stroke/TIA, 임신/산후 중증 고혈압도 기다리지 않는다.

- 가정혈압 기록을 먼저 본다. 없으면 오늘 수치만으로 과격하게 조정하지 않는다.
- 흉통, 숨참, 신경증상, 시야장애, 의식 변화, 심한 두통을 확인한다.
- 약 이름, 복용 시간, 빠뜨린 횟수, 부작용, 약국 대체 여부를 확인한다.
- ARB/ACEi, thiazide, spironolactone 사용자는 Cr/eGFR, K, Na 추적 필요성을 확인한다.
- 오늘 결론을 증량, 병합, 변경, 의뢰 중 하나로 정한다.

3. 핵심 문진 5문항

- 집 혈압은 아침·저녁 평균이 얼마였는가?
- 약을 일주일에 몇 번 빠뜨렸고, 언제 복용하는가?
- 어지럼, 실신 느낌, 발목부종, 마른기침, 근육경련, 성기능 저하가 있었는가?
- 진통제, 감기약, 스테로이드, 한약/보충제, 다이어트약, 피임약을 새로 시작했는가?
- 염분 많은 식사, 음주, 코골이/수면무호흡, 체중 증가가 있었는가?

4. 꼭 해야 할 Physical Exam

- 혈압 재측정: 5분 안정 후 같은 팔·같은 자세. 양팔 차이가 컸다면 높은 쪽 기준.
- 기립저혈압: 고령, 어지럼, 낙상, 당뇨 자율신경병증, 다약제 환자에서 확인.
- 맥박수와 리듬: 서맥, 빈맥, 불규칙 맥박. beta-blocker 조정과 AF 단서.
- 체중, 발목부종: CCB 부종, 심부전, 신장질환, 염분 섭취 평가.
- 심폐청진, 말초맥박, 복부 bruit: 심부전·판막질환·혈관질환 단서.

5. 검사

상황	검사	해석/행동
ARB/ACEi 시작 또는 증량	Cr/eGFR, K	2-4주 내 확인. Cr 30% 이상 상승 또는 K 상승이면 원인 확인·감량/중단 고려.
Thiazide 사용	Na, K, Cr/eGFR, uric acid	저Na/저K, 탈수, 통풍 악화 확인.
Spironolactone 고려	Cr/eGFR, K	eGFR 낮거나 K 높으면 시작 금물 또는 전문의 상의.
조절 불량 지속	UA, urine ACR, HbA1c, lipid, ECG	CKD/당뇨/표적장기손상 확인.
두근거림/불규칙 맥	ECG	AF, 빈맥, 서맥 확인.

상급병원 검사는 심초음파, 신장초음파/신동맥 평가, renin/aldosterone, 수면다원검사, 24시간 활동혈압검사를 상황별로 의뢰한다.

6. KCD 코드

코드	상황
I10	본태성 고혈압. 추적·약물 조정의 주상병.
I11.x	고혈압성 심장병. 심부전/좌심실비대 등 근거가 있을 때.
I12.x	고혈압성 신장병. CKD와 고혈압의 관련성이 기록될 때.
I13.x	고혈압성 심장 및 신장병. 심장·신장 침범이 함께 명확할 때.
N18.x / E78.x / E11.x	CKD, 이상지질혈증, 당뇨 동반 시 부상병 후보.
R60.0 / R42	부종 또는 어지럼 평가가 필요한 경우.

상병코드는 실무 후보이며, 최종 청구는 실제 진단 근거, 검사 결과, 차팅 내용에 맞춰 조정한다.

7. 처방 Regimen

목표 미달 시 기본 알고리즘

1. 가정혈압 평균과 복약 순응도를 확인한다.
2. NSAID, 감기약, 스테로이드, 과음, 염분, 체중 증가, 수면무호흡을 교정한다.
3. 단독 저용량이면 표준용량으로 증량하거나 다른 계열을 병합한다.
4. 2제 병합에도 목표 미달이면 RAS blocker + CCB + thiazide/thiazide-like 3제를 고려한다.
5. 이뇨제 포함 3제에도 조절이 안 되면 resistant HTN 가능성을 보고 의뢰 또는 4제 조정을 검토한다.

현재 처방	목표 미달 시	주의
Amlodipine 5 mg qd	10 mg qd 또는 ARB 추가	부종 있으면 증량보다 ARB 병합/CCB 감량.
Losartan 50 mg qd	100 mg qd 또는 amlodipine 5 mg 추가	K/Cr, 임신 가능성 확인.
Telmisartan 40 mg qd	80 mg qd 또는 CCB 추가	K/Cr, 어지럼 확인.

현재 처방	목표 미달 시	주의
ARB/CCB 저용량 복합제	각 성분 증량 또는 thiazide 계열 추가	eGFR, Na/K, 요산 확인.
2제 표준용량에도 미달	ARB + CCB + thiazide-like 3제	저Na/저K, 탈수, 통풍, CKD 주의.

약제별 부작용 대응

약제	흔한 문제	의원 대응
CCB	발목부종, 홍조, 두근거림	심부전/신장질환 배제. 용량 감량, ARB 병합, 계열 변경.
ACEi	마른기침, 혈관부종, Cr/K 상승	기침 지속 시 ARB 전환. 혈관부종은 중단·응급 평가.
ARB	Cr/K 상승, 어지럼	NSAID/탈수/CKD 확인. 임신 가능성 있으면 금기.
Thiazide	저Na/저K, 고요산혈증, 탈수	고령·저체중·통풍·eGFR 저하에서 주의.
Beta-blocker	서맥, 피로, 성기능 저하, 기관지수축	천식/COPD, HR 낮은 환자 주의. 적응증 있을 때 선택.
Spironolactone	고K, 여성형유방, Cr 상승	Resistant HTN 4제 후보. eGFR/K 확인 후 신중히.

안전 체크: eGFR, K, Na, 임신 가능성, 고령/frailty, 항응고제, NSAID, PPI 장기복용, BZD, quinolone, steroid 사용을 확인한다. ARB/ACEi/이뇨제/spironolactone 조정 후에는 신기능과 전해질 추적 일정을 차팅한다.

8. Follow-up

- 약 시작 또는 증량 후: 2-4주 뒤 혈압, 부작용, 순응도 확인.
- ARB/ACEi/이뇨제/spironolactone 조정 후: 2-4주 내 Cr/eGFR, K, Na 확인.
- 안정화 후: 1-3개월 간격, 이후 조절 안정·순응도 좋으면 3개월 단위.
- 고령, CKD, 전해질 이상, 다약제: 더 짧게 추적.

치료 실패는 가정혈압 평균 135/85 이상 반복, 진료실 140/90 이상 2회 이상 지속, 2제 이상 표준용량에도 목표 미달, 이뇨제 포함 3제에도 조절 불량, 또는 검사 이상으로 일반 증량이 어려운 경우로 본다.

9. Refer 기준

- 응급: 표적장기손상 증상 동반, ACS/stroke/TIA/대동맥박리/급성 심부전 의심, K 6.0 이상, 급성 신손상, 임신/산후 중증 고혈압.
- 빠른 외래: Cr/eGFR 급격 악화, 단백뇨/혈뇨, 반복 저칼륨혈증, 30세 이전 중증 고혈압, resistant HTN.
- 계획 의뢰: 수면무호흡, 활동혈압검사 필요, 2차성 고혈압 평가, 표준 병합치료 유지가 어려운 부작용.

10. 환자 설명 스크립트

오늘 혈압이 높다고 바로 약을 많이 올리지는 않겠습니다. 집에서 잤 평균과 실제 복용 여부를 같이 봐야 과하게 떨어뜨리는 일을 피할 수 있습니다.

한 가지 약을 끝까지 세게 쓰는 것보다, 서로 다른 약을 낮은 용량으로 같이 쓰는 편이 혈압은 더 잘 잡히고 부작용은 줄어드는 경우가 많습니다.

발목이 붓거나 어지럽거나 기침이 생기는 것은 참으면서 드실 문제가 아닙니다. 약을 바꾸거나 용량을 조정할 수 있으니 먼저 알려주셔야 합니다.

진통소염제, 감기약, 스테로이드, 술, 짠 음식, 수면무호흡이 혈압을 올릴 수 있습니다. 약을 늘리기 전에 이런 원인을 같이 줄여야 합니다.

가슴통증, 숨참, 한쪽 마비, 말 어눌함, 갑자기 심한 두통, 시야장애가 있으면 혈압약을 추가로 먹고 기다리지 말고 응급실로 가셔야 합니다.

11. 자가체크

1. 고혈압 재진에서 약 증량 전 반드시 확인할 3가지는?
2. Amlodipine 복용 후 발목부종이 생긴 환자에서 가능한 대응은?
3. ARB 증량 후 확인해야 할 검사와 위험 소견은?
4. Resistant hypertension의 실무적 정의와 의뢰 기준은?
5. 혈압 조절을 방해하는 흔한 약물/생활요인 5가지는?

참고 출처

Korean Society of Hypertension 2022 focused update: <https://clinicalhypertension.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40885-023-00234-9>

KSH Resistant hypertension consensus: <https://clinicalhypertension.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40885-023-00255-4>

2024 ESC Guidelines for elevated BP and hypertension: <https://academic.oup.com/eurheartj/article/45/38/3912/7741010>